·专题笔谈·

《中国流感治疗与药物预防临床实践指南（2025版）》解读

王业明[1,2]　李靓雅[3]　陈思颖[1]　曹彬[1,2,4,5]

[1]中日友好医院呼吸与危重症医学科，北京 100029；[2]首都医科大学呼吸病学系，北京 100069；[3]清华大学基础医学院，北京 100084；[4]国家呼吸医学中心，北京 100029；[5]中日友好医院新基石科学实验室，北京 100029

通信作者：曹彬，Email：caobin_ben@163.com

【摘要】《中国流感治疗与药物预防临床实践指南（2025版）》（以下简称指南）由中华医学会呼吸病学分会与感染病学分会联合正式发布。作为一部基于循证医学方法制订的流感治疗与药物预防临床指南，其核心亮点在于提供了系统性、可操作的循证指导。本文旨在对该指南进行解读，阐述其相较于既往共识的五大重要进展：方法学创新、治疗策略分层化、整合国产创新药物的新证据、明确治疗窗口期、预防策略的明晰化。该解读旨在帮助临床工作者深入理解指南的核心理念与临床考量，推动其有效实施。

【关键词】 流感，人；　治疗；　药物预防；　临床实践指南

基金项目：北京市卫生健康委研究型病房卓越临床研究计划（BRWEP2024W114060108）

Interpretation of"Clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of influenza in China (2025 edition)"

Wang Yeming[1,2], Li Jingya[3], Chen Siying[1], Cao Bin[1,2,4,5]

[1]Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, China-Japan Friendship Hospital, Beijing 100029, China; [2]Department of Respiratory Medicine, Capital Medical University, Beijing 100069, China; [3]School of Medicine, Tsinghua Medicine, Tsinghua University, Beijing 100084, China; [4]National Center of Respiratory Medicine, Beijing 100029, China; [5]New Cornerstone Science Laboratory, China-Japan Friendship Hospital, Beijing 100029, China

Corresponding author: Cao Bin, Email: caobin_ben@163.com

【Abstract】 "Clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of influenza in China (2025 edition)" (hereinafter referred to as"the Guideline") were jointly released by the Chinese Thoracic Society and Chinese Society of Infectious Diseases of the Chinese Medical Association. As an influenza guideline developed using evidence-based methodology in China, its key strength lies in providing systematic and actionable recommendations grounded in evidence. This article aims to provide a clinical interpretation of the Guidelines, highlighting five major advancements compared with previous consensus documents: methodological innovation, stratified treatment strategies, integration of new evidence on domestically developed innovative drugs, clarification of the therapeutic window and explicit preventive strategies. This interpretation is intended to assist clinicians in thoroughly understanding the core principles and clinical considerations of the guideline, thereby promoting effective implementation.

【Key words】 Influenza, human;　Treatment;　Prophylaxis;　Clinical practice guideline

Fund program: Beijing Municipal Health Commission Research Ward Excellence Clinical

DOI：10.3760/cma.j.cn112137-20251130-03131

收稿日期　2025-11-30　　**本文编辑**　罗茜

引用本文：王业明，李靓雅，陈思颖，等.《中国流感治疗与药物预防临床实践指南（2025版）》解读[J]. 中华医学杂志，2026，106(8)：703-705. DOI：10.3760/cma.j.cn112137-20251130-03131.

Research Program Project (BRWEP2024W114060100)

流行性感冒(以下简称流感)是一种传播速度快、季节性流行显著的急性呼吸道传染病,每年全球新发数百万例重症病例,导致约50万人死亡,对社会造成沉重负担[1-2]。尽管流感防控历来受到重视,但我国临床医师在抗病毒治疗与药物预防的实践中,面临国内循证指南空白的困境。《中国流感治疗与药物预防临床实践指南(2025版)》(以下简称指南)的发布,有效填补了这一空白[3]。本文将从临床医师的视角,深入剖析指南的核心亮点及其对临床实践可能产生的深远影响。

一、指南背景:从专家共识到循证指南的跨越

我国既往流感诊疗多依赖专家共识,缺乏系统、透明的证据评价与推荐流程。本指南首次采用国际通用的推荐意见分级的评估、制订及评价(GRADE)方法[4]与指南科学性(Scientific)、透明性(Transparent)和适用性(Applicable)的评级(Rankings)(简称"STAR")推荐制修订决策框架,系统检索、评价并整合全球高质量研究,形成涵盖抗病毒治疗、辅助治疗和药物预防三大领域的21条核心推荐意见,具备高度的科学性与权威性。与国内外既往指南共识相比,本指南在方法学规范、证据整合和临床适用性方面进行了系统完善。其基于系统证据检索形成循证推荐,纳入国产药物,并对不同人群进行分层推荐,同时覆盖儿童、重症等特殊人群。此外,本指南采用"动态指南"(live guideline)模式,将定期评估新证据并及时更新推荐意见,确保持续反映最新科研进展,为临床实践提供前沿且可靠的指导。本指南的发布在一定程度上推动了我国流感诊疗决策的规范化和循证化。

二、适用场景与人群:覆盖全人群,关注特殊群体

本指南适用于各级医疗机构,目标人群涵盖所有流感患者及有药物预防需求者。值得关注的是,指南针对儿童、孕产妇、老年人、合并慢性基础疾病者等高危人群,设置了专门的临床问题与推荐意见,体现了精准化、个体化的管理思路。在儿童流感管理方面,指南明确推荐对<2岁患儿(GRADE分级2C)、重症患儿(1B)、合并高危因素者的患儿(2C)常规进行抗病毒治疗,并对儿童用药注意事项作出说明,包括可根据年龄和耐受程度选择颗粒、干混悬剂、胶囊等多种剂型,同时强调儿童剂量需根据年龄和体重进行调整,避免超剂量使用。对于老年人,指南将年龄>65岁明确列为独立危险因素,且老年患者常合并多种基础疾病,需高度重视流感病毒感染的早期识别及抗病毒治疗的快速启动。对于孕产妇,抗病毒用药不仅关系孕产妇自身健康,也可能影响胎儿及新生儿,指南基于现有安全性证据,仅推荐奥司他韦作为首选用药,暂不推荐其他证据不足的药物。这些细化建议填补了既往共识中对特殊人群管理不足的空白。

三、循证为本:证据驱动推荐,不以直觉定策略

本指南严格遵循GRADE方法,将证据质量分为高、中、低、极低四个等级,推荐强度分为强推荐与弱推荐。所有推荐均基于当前最佳证据,而非专家个人经验。典型例证是重症流感患者的药物选择。尽管玛巴洛沙韦等新型RNA聚合酶抑制剂在非重症人群中显示出优异疗效,但由于其在重症患者中的证据尚不充分,本指南仍将奥司他韦作为重症患者的首选用药(1B),并指出"其临床应用策略仍需更多高质量研究进一步明确"。这体现了指南"有证据用证据,无证据促研究"的严谨态度。

四、重视国产原研药物:科学评价,合理推荐

近年来,我国自主研发的多个抗流感病毒药物陆续上市,如玛舒拉沙韦、玛硒洛沙韦、昂拉地韦等[5-8]。这些药物并非仿制品,而是具有全新结构的原研药。本指南在系统审阅其Ⅱ/Ⅲ期临床试验结果的基础上,将其纳入推荐。例如,对于无高危因素的非重症成人患者,指南将上述国产新型原研药物列为可选方案(2C),这不仅为临床医师和患者提供了更多治疗选择,也体现了对国产创新药物的科学认可与支持。

五、早治疗、早干预:把握"48 h黄金窗口"

抗病毒治疗的时机是影响疗效的关键因素[9-10]。本指南在多处强调"应尽早开始,最好在症状出现后48 h内"。无论是非重症高危人群、重症患者,还是儿童,早期治疗均被证实可显著缩短病程、降低重症风险。此外,指南并未将48 h绝对化,而是体现了重要的临床灵活性:对于症状持续超过48 h且病毒核酸仍阳性的患者,仍可考虑抗病毒治疗。这提示临床医师,"治疗窗口"应结合患者的病情严重程度和病毒清除情况综合判断。

六、药物预防与疫苗：主次分明，定位清晰

在流感预防方面，本指南虽以“药物预防”为核心，但明确强调：接种流感疫苗是防流感最有效、最经济的手段，抗病毒药物不能替代疫苗。一项2025年的荟萃分析（n=192 705）显示，接种流感疫苗对预防甲型流感病毒H1N1亚型（OR=0.46，95%CI：0.41~0.52）、H3N2亚型（OR=0.76，95%CI：0.69~0.85）和乙型流感病毒（OR=0.48，95%CI：0.41~0.58）均具有显著保护作用，可明确降低实验室确诊的有症状流感的发生率。此外，接种流感疫苗可降低死亡率，对甲型流感病毒H1N1亚型、H3N2亚型及乙型流感的保护效力分别为55.76%、67.08%和36.25%[11]。然而，由于患者与医务人员认知不足、预防接种服务体系不完善以及费用等原因，我国流感接种率远低于国际推荐标准[12]。

在“疫苗优先”的基本原则下，指南对药物预防的“补充”和“替代”角色进行了清晰界定，仅推荐在特定情况下使用，如高危人群存在疫苗禁忌、接种后免疫应答不足、或与未接种疫苗的高危者共同居住等。且在暴露后抗病毒药物预防方面，指南仅推荐在暴露后48 h内尽早启动（2B），超过48 h则不推荐（2D）。这些推荐意见有助于纠正“重药物、轻疫苗”的误区，引导公众与医务工作者树立“疫苗优先”的科学防控理念。

此外，本指南未对疫苗与抗病毒药物联合使用作具体说明。《中国流感疫苗预防接种技术指南（2025-2026）》指出，对于正在使用抗病毒药物且有流感疫苗接种需求的人群，服用流感抗病毒药物进行预防和治疗期间，可以接种流感病毒灭活疫苗；但不建议使用流感病毒减毒活疫苗，因为抗病毒药物会影响其接种后的免疫反应，导致预防效果不佳[13]。需要强调的是，目前尚无证据表明流感病毒灭活疫苗与抗病毒药物联用相较于单独采用任意措施能够进一步提高预防效果。

综上，《中国流感治疗与药物预防临床实践指南（2025版）》是我国流感防控领域的一座里程碑。它不仅在方法学上实现了与国际接轨，而且在内容上紧密结合了我国国情与临床实际。尤其注重对特殊人群的管理与国产原研药物的科学评价。希望本指南能为广大临床工作者提供清晰、可靠、可操作的实践依据，共同推动我国流感整体防治水平的提升。

利益冲突　曹彬、王业明参与玛巴洛沙韦和玛舒拉沙韦的临床试验；其他作者声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] World Health Organization. Influenza (seasonal) [EB/OL]. (2025-02-28) [2026-01-06]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal).

[2] 王铭韩，胡泽鑫，冯录召，等. 新型冠状病毒感染疫情后我国季节性流感的流行趋势与防控建议[J]. 中华医学杂志，2024，104(8)：559-565. DOI：10.3760/cma.j.cn112137-20231220-01430.

[3] 中华医学会呼吸病学分会，中华医学会感染病学分会. 中国流感治疗与药物预防临床实践指南(2025版)[J]. 中华医学杂志，2026，106(2)：122-139. DOI：10.3760/cma.j.cn112137-20251120-03042.

[4] Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, et al. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations[J]. BMJ, 2008, 336(7650): 924-926. DOI: 10.1136/bmj.39489.470347.AD.

[5] Li J, Jin Y, Wang Y, et al. New developments in influenza polymerase inhibitors[J]. J Infect Dis, 2025, 232(Supplement_3):S227-S242. DOI: 10.1093/infdis/jiaf126.

[6] Wang Y, Wang H, Zhang Y, et al. Single-dose suraxavir marboxil for acute uncomplicated influenza in adults and adolescents: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial[J]. Nat Med, 2025, 31(2): 639-646. DOI: 10.1038/s41591-024-03419-3.

[7] Wang H, Wang G, Gao Y, et al. Efficacy and safety of ZX-7101A, an inhibitor of influenza cap-dependent endonuclease, in adults with uncomplicated influenza: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 2/3 trial[J]. Clin Microbiol Infect, 2025, 31(2): 274-281. DOI: 10.1016/j.cmi.2024.10.020.

[8] Yang Z, Zhan Y, Li Z, et al. Efficacy and safety of onradivir in adults with acute uncomplicated influenza A infection in China: a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled and oseltamivir-controlled, phase 3 trial[J]. Lancet Respir Med, 2025, 13(7): 597-610. DOI: 10.1016/S2213-2600(25)00046-3.

[9] Gao Y, Zhao Y, Liu M, et al. Antiviral medications for treatment of nonsevere influenza: a systematic review and network meta-analysis[J]. JAMA Intern Med, 2026, 185(3): 293-301. DOI: 10.1001/jamainternmed.2024.7193.

[10] Gao Y, Guyatt G, Uyeki TM, et al. Antivirals for treatment of severe influenza: a systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials[J]. Lancet, 2024, 404(10454): 753-763. DOI: 10.1016/S0140-6736(24)01307-2.

[11] Presa J, Arranz-Herrero J, Alvarez-Losa L, et al. Influenza vaccine outcomes: a meta-analysis revealing morbidity benefits amid low infection prevention[J]. Eur Respir Rev, 2025, 34(175)DOI: 10.1183/16000617.0144–2024.

[12] 贾萌萌，冯录召. 中国老人流感疫苗接种的现状、挑战与对策建议[J]. 中华医学杂志，2025，105(2)：123-127. DOI：10.3760/cma.j.cn112137-20240826-01962.

[13] 国家免疫规划技术工作组流感疫苗工作组，郑建东，王大燕，等. 中国流感疫苗预防接种技术指南(2025-2026)[J]. 中华流行病学杂志，2025，46(12)：2097-107. DOI：10.3760/cma.j.cn112338-20251111-00813.